标注手册 V3.1 • 外部站点附录（v0）

状态：v0（2026-10-15，随外部站点双域空白标注包首发）——外部验证（外部站点 ECG + 腹部超声双域）随包分发件，**替代 pilot 培训试标的口径校准职能**

适用任务：外部站点双域盲标（ECG 300 份 + ABD 300 份，A1/A2 同表分栏，另 10% 自重复质控）

与《标注手册 V3.1》的关系：本附录**不新增、不修改、不回改** V3.1 正文任何 flag 定义、结局三分类定义、V3.0-1～V3.0-12 条款。本附录只做三件事：①登记外部站点文本形态的实测事实，使标注员对文体差异有预期；②指明外部站点特异性情形**适用 V3.1 的哪一条既有口径**（指路，不立新规）；③规定口径空白的上报与增补流程。

升版约束：若外验过程中出现**新站点裁决条款**（既有 V3.1 无法覆盖的实质口径），按 V3.1 版本阶梯升 **V4.0** 作为外验 codebook 锚点；仅外部站点个案留痕与文体提示则在本附录内按轮次增补（v0 → v1 → …），V3.1 正文内容保持不变。

上游依据：外部验证协议（§3/§5）；外部站点 codebook 执行细则；OSF 研究 B Amendment 1（GUID `y4kh6`，DOI `10.17605/OSF.IO/6SKJE`）

一、任务背景与盲法声明

本轮为**外部验证**：把索引站点上已冻结的抽取系统整体搬到第二 provider（外部站点）的文本上运行，与您独立作出的人工参照标准比较。您标注的对象是**参照标准本身**，不是"系统对不对"——系统输出在标注全部回传并仲裁裁定完成后才解盲比对，本轮标注包中**不含任何机器抽取结果。**

盲法声明：标注包中不含检查年份、样本来源分层、伪标识、任何历史标注或系统输出。请勿向课题组索要上述信息。**判读没有预设的标准答案**——我们要如实采集的是您依《手册 V3.1》精神作出的独立判断，包括您与另一位标注员的分歧本身。

与既往两轮的定位差异：第一轮金标准（1,470 份）是"建标准"，第二轮四域定义对齐（560 份 + 自重复）是"对齐口径"，本轮第三轮是"在陌生文本环境上验证口径的可迁移性"。因此本轮**不追求与既往轮次一致**，而追求**两位标注员之间一致**且**各自稳定。**

二、本轮不设 pilot 培训试标（预注册偏离的书面说明）

原方案（OSF Amendment 1 §C）列有 pilot-first calibration：每域 20 份试标 + 课题组核对口径后再开全量，任一域出现 ≥3 例同型系统性歧义即暂停。

本轮取消 pilot，理由：标注员与仲裁员已深度参与前两轮工作，对 V3.1 codebook、结局三分类与分站 outcome 口径充分熟悉，培训性试标的边际信息量低。

替代性口径校准 = 本附录 v0（书面锚定，见 §四）+ **保留原 pilot 的暂停门**：标注过程中若任一域出现 **≥3 例同型系统性歧义**，即暂停该域剩余标注，先完成条款增补（本附录升版或 V3.1 → V4.0）再继续（详见 §六-4）。此门为 Amendment 1 中 pilot 规则的实质保护部分，取消 pilot 后**继续生效**，且可由标注员在标注途中直接触发，不必等到全量回传。

样本量与抽样不受影响：无 pilot 集，全部 300 份/域均为正式性能集。

> 本偏离按预注册约定如实披露，性质同研究 A 早先取消 pilot 的先例；已记录于抽样方案文档，并将进入稿件 Registration deviations 节。

三、外部站点文本形态实测事实（透明度登记，不构成判读规则）

以下数字由确认性抽样脚本在冻结抽样框上实测得到，仅供您建立文体预期。**请勿据此推断任何单份记录应如何判读。**

维度	ECG 域（300 份）	ABD 域（300 份）
文本长度（字符）	min 1 / **median 5** / max 41	min 2 / **median 7** / max 53
去重后不同文本数	95 / 300	143 / 300
最高频单一文本	"正常"，占 25.3%	"未见异常"，占 17.0%
前 5 高频文本合计占比	53.3%	39.3%
含内嵌换行（多脏器/多行结论拼接）	53 份	102 份
拒检/未做类文本	6 份（"拒做"/"拒绝"）	3 份（"未做"）
是否被 150 字符截断	**无**（分发全文均 <150）	**无**

三点提示：

1. **外部站点文体是"体检结论式"超短文本**，与索引站点（基层站点/医院站点）的叙述式报告差异显著：索引站点常见"肝脏大小形态正常，实质回声均匀，未见明显异常回声"这类完整句，外部站点常只有"未见异常"四字。**这不是数据缺陷，是第二 provider 的真实书写习惯**，也正是外部验证要检验的泛化压力来源。

2. **文本高度重复是数据事实。**同一句"正常"在包内可能出现数十次。请**逐份扫读原文后填写**，禁止整列批量填同一值（V3.1 §五-2）；即便内容相同，每行仍需独立完成填写动作。

3. **分发文本为未截断全文**（协议 v2.0 §5 文本完整性条款）。抽样框按 150 字符截断层建立，标注文本一律取全文并按同一掩码规则处理；已核验两域各 300/300 通过。故本包**不存在"文本被截断导致信息丢失"的情形**，请勿以"疑似截断"作为 `uninterp_reason` 的理由。

4. **分发文本已做行尾签名脱敏**：外部站点原始结论文本行尾偶有检查医生签名残留（实测 30 份），生成时已按行尾签名模式移除（全文与截断层的一致性核验在脱敏**之前**完成，临床内容未改动；脱敏为课题组去标识义务，与判读无关）。请勿以"疑似缺签名/文本被删改"作为判读或 `note` 填报事项。

四、口径锚定（指路条款，均引 V3.1 既有规定）

EXT-v0-1 双域通用：简短记录照实判读

V3.1 §三"关于稀疏/简短记录的特别说明"在外部站点 **高频适用**（median 5–7 字符）：若您认为该内容足以支持某归类，按您的判断填写；若认为信息不足，填 `outcome=0` 并在 `uninterp_reason` 选 **3（信息不足）**。此类记录的归类正是本轮采集对象，**不存在对错预设**，也**不提供示例判定以避免锚定。**

EXT-v0-2 双域通用：结局判读独立于 flag 填写

先作临床判读、后录 flag，两者允许不一致（V3.1 §三）；不一致本身如实填写即可，不必修饰为一致。

EXT-v0-3 双域通用：拒检/未做类文本

"拒做""拒绝""未做""弃检""×"及空白等，属 V2.0 各域 `unreadable` 定义情形（V3.1 §一 flag 表 `ecg_unreadable` / `us_unreadable` 行）→ 对应 `A?_ecg_unreadable=1`（或 `A?_us_unreadable=1`）、`A?_outcome=0`、`A?_uninterp_reason=1`（文本缺失/弃检/拒检/无有效内容）。ECG 域另有"伪差/图像质量不佳/建议复查"明示情形，见 V3.0-10。

EXT-v0-4 双域通用：多行拼接文本

含内嵌换行的记录（ECG 60 份、ABD 112 份）为同一次检查的多行结论/多脏器所见拼接，**按整体一份记录判读**，不拆分为多例：任一异常 flag 阳性即 `outcome=2`，`abnormal_basis` 逐项列出全部依据词句。

EXT-v0-5 ECG 域：flag 与结局一律按 V2.0 域① 定义

12 项 flag（`ecg_normal/ecg_af/ecg_pac_pvc/ecg_stt/ecg_avblock/ecg_bbb/ecg_rate/ecg_srirr/ecg_axis/ecg_qwave_mi/ecg_other/ecg_unreadable`）定义与索引站点完全一致，无外部站点特异调整。特别提示两条既有定版条款在外部站点短文本上的适用：**V3.0-9**（左心室高电压/早期复极 = 正常变异，不计入

ecg_other；短 P-R 正常 QRS 波群综合征计入）与 **V3.0-10**（明示伪差/图像质量不佳/建议复查 → ecg_normal=0、ecg_unreadable=1、outcome=0）。

EXT-v0-6 ABD 域：适用 V3.0-1a 之基层站点（从严）聚合口径

外部站点 B 超文本**无"主检结果"字段**（纯所见文本），与索引站点的基层站点文本形态同构，故 outcome 聚合按 V3.0-1a **基层站点从严**分支：

• 脂肪肝 / 胆囊胆管结石 / 胆囊切除术后 / 实质性占位 / 肝硬化 / 血吸虫 → outcome=2

• **孤立良性发现（囊肿 / 息肉 / 结晶 / 血管瘤）** → outcome=1（即不计为异常结局；相应 flag 仍照实填 1）

• 囊肿大小阈值（长径 ≥10mm）**仅适用于** us_hepatic_other **flag**（V2.0 原文"肝囊肿(>10mm)"），**基层站点 outcome 不设阈值**——请勿因"囊肿 38mm"而将孤立肾囊肿/肝囊肿升为 outcome=2

• 医院站点（hospital site）的 any-abnormal 分支**本轮不适用**

EXT-v0-7 ABD 域：main_discrepant 列本轮不存在

V2.0 域④（医院站点）的"主检与超声不一致"列依赖主检结果字段，外部站点无该字段，故本包 ABD 表**无 main_discrepant 列**（与研究 A 的基层站点包一致）。请勿手工增列。

EXT-v0-8 ABD 域：us_fatty_degree 填写规则

原文出现程度词才填"轻/中/重"；**若 us_fatty=1 而原文未明示程度，按 V3.0-3 一律记"轻度"。**两点依据：① V3.0-3 位于手册第三部分（定版条款），依其开头声明，与第一、二部分冲突时以第三部分为准——V3.1 §四"原文出现才填，否则空"的一般填写规则在这一点上让位于 V3.0-3；② 冻结抽取系统对 us_fatty=1 且无程度词的文本同样缺省输出"轻度"，参照标准与被测系统口径对齐方可保证解盲后 flag 级一致性可比。外部站点短文本多数不含程度词，"轻度"缺省为常态，如实填写即可。

EXT-v0-9 阴性所见与"留空"惯例

二值 flag 列：阳性填 1，**明确阴性或原文未提及一律填** 0（不留空）。可留空的仅限分级/数值列（us_fatty_degree）。A?_outcome 三列（outcome / abnormal_basis / uninterp_reason）为**必填**：判 2 必填 abnormal_basis，判 1/0 时 abnormal_basis 填"无"，判 0 必填 uninterp_reason 代码 1–4。

EXT-v0-10 A?_note 列的用法

以下情形请在 note 用一句话留痕（可空，但下列情形**建议必填**）：

• 您认为存在 V3.1 未覆盖的口径空白（→ 同时按 §六 上报课题组）

• 域错配嫌疑（如腹超/尿检内容出现在 ECG 包）→ outcome=0、uninterp_reason=2，并在 note 写明

• ABD 域含"左/右/双"侧别、息肉或囊肿大小等需保留的细节（V2.0 域③④ note 惯例）

• 文本疑似脱敏掩码残留、乱码、明显数据质量问题（→ 报课题组，勿自行改文本）

五、本包列结构（与 V3.1 §四 一一对应）

两包均为 CSV（UTF-8 with BOM，Excel 可直接打开），A1/A2 **同表分栏**：A1 只填 A1_ 开头的列，A2 只填 A2_ 开头的列，双方互盲。

ECG 包（35 列）：sample_id、text + 每位标注员 16 列（12 flag + outcome、abnormal_basis、uninterp_reason、note）+ arbitration

ABD 包（23 列）：`sample_id`、`text` + 每位标注员 10 列（6 变量：`us_fatty`、`us_fatty_degree`、`us_hepatic_other`、`us_gallstone`、`us_kidney_cyst`、`us_unreadable` + `outcome`、`abnormal_basis`、`uninterp_reason`、`note`）+ `arbitration`

三点与既往轮次的差异：

1. **无源信息列**（`year/exam_date/pseudo_id` 均不分发）——盲法要求，比前两轮更严。

2. `arbitration` **列标注员勿填**，仅分歧个案由仲裁员在课题组回传后填写。

3. 标注表说明文档中描述的**顶层** `flag/note` **列本轮不适用**（本轮 note 内嵌于各标注员的 `A?_note`）；该文档其余列定义仍适用；其中"一致性计算"所引脚本为课题组内部工具，**专家无需运行任何脚本**，一致性由课题组统一计算。

4. **《标注手册 V3.1》第二部分 §六"工作量与交付"为既往轮次时点内容**（确认层 140 例/域 × 4 域、另有 pilot 20 例/域、"分发 → pilot 校准"时序），**本轮不适用**；本轮工作量与流程以本附录 §七与《外部验证专家咨询问卷 v2》为准（ECG 300 + ABD 300 + 自重复 60 份/人，**无培训试标**）。

编号说明：`EXTECG-001…300`、`EXTABD-001…300`
为域内中性乱序编号，与年份、分层、原始记录顺序**无任何对应关系**，请勿据编号推测来源。

六、口径空白的处置流程（重要）

外验的核心风险是"新文本形态撞上旧口径"。请按以下流程处置，**不要自行创立新规则**，也**不要为了让两人一致而修饰判断**：

1. **照实判读**：依 V3.1 精神与您自己的临床判断填写，允许与另一位标注员不一致。

2. **note 留痕**：在 `A?_note` 一句话写明疑点（如"外部站点写法 X，V3.1 无对应条款，按 Y 判"）。

3. **上报课题组**：回传前将疑点清单（含 `sample_id`）发课题组；课题组汇总同型情形。

4. **增补路径**：

• 属**个案留痕 / 文体提示** → 增补入本附录（v0 → v1），V3.1 正文不动；

• 属**新站点实质裁决条款** → 升 **V4.0**（外验 codebook 锚点），并在 OSF 以 amendment/comment 披露时序；

• 任一域出现 **≥3 例同型系统性歧义** → 暂停该域剩余标注，先完成条款增补再继续（此门为原 pilot 规则的等价替代，本轮继续生效）。

5. **仲裁**：A1≠A2 的 flag 或结局**全量逐条交仲裁**（V3.1 §五-5，无规则短路），仲裁裁定附理由即 panel 判定；仲裁意见只增补本附录，不回改 V3.1 正文。

七、独立性、质控与交付

项	要求
独立判读	A1/A2 互盲独立，全部完成并回传前不得交流或披露中间结果
逐例判读	禁止整列批量填同一值；每份均需扫读原文（外部站点文本重复率高，尤须注意）
依据留痕	判 2 必填 `abnormal_basis` 依据词句；判 0 必填 `uninterp_reason` 代码
按序完成	按包内顺序逐行；跳过的行留空并在 `note` 注明 `sample_id`
系统性歧义暂停门	任一域 ≥3 例同型系统性歧义 → 暂停该域剩余标注并报课题组（§六-4）
自重复（组内 κ）	全量完成后**间隔 ≥3 天**，每人对其中的 10%（**30 份/域**）重标；重标包由课题组另行分发（编号已重排，不可对照首轮答案）。门同研究 A：`outcome` intra-rater κ ≥0.85
交付	标注列填写完整后**原样回传**（勿改列名、勿改 `sample_id/text`、勿增删行列）；回传由课题组统一登记
解盲次序	抽取系统输出在标注回传并仲裁裁定完成后才与人工参照比对；监测器信号计算与人工标注互不依赖

工作量参考：外部站点文本极短，单份判读显著快于索引站点；ECG 300 + ABD 300 + 自重复 60 合计 660 份/人。

判定口径、列结构或文件问题，请随时联系课题组（the study team）。

版本记录

v0（2026-10-15，随外部站点双域空白标注包首发）

1. **替代 pilot 职能**：以书面口径锚定（§四 EXT-v0-1 ~ EXT-v0-10）替代原 pilot 20 份/域培训试标；pilot 取消作为预注册偏离披露（Amendment 1 GUID `y4kh6` §C）。无 pilot 集，300 份/域全为正式性能集。

2. **登记外部站点文体实测事实**（§三）：结论式超短文本（ECG median 5 / ABD median 7 字符）、文本高重复、内嵌换行拼接、分发全文未被 150 字符截断。

3. **锚定 ABD 域分站口径**：外部站点无主检字段 → 适用 V3.0-1a **基层站点从严**分支（孤立良性发现→1，outcome 不设囊肿阈值）；`main_discrepant` 列本轮不存在。

4. **明确升版约束**：本附录不新增、不回改 V3.1 正文；新站点实质裁决条款一律升 V4.0。

5. **保留原 pilot 的暂停门**：任一域 ≥3 例同型系统性歧义即暂停该域剩余标注（§六-4）。

6. **首次分发前修订**：①**签名脱敏**——原始文本行尾残留检查医生签名 30 份（ECG 6 / ABD 24，11 人），抽样脚本在全量一致性核验之后、落盘之前按行尾签名模式移除（只删签名段，临床内容未改动），§三表格数字随之更新（去重 95/143、前 5 高频 53.3%/39.3%、内嵌换行 53/102 份）并新增提示 4；②**EXT-v0-8 口径改写**——`us_fatty=1` 且原文未明示程度 → 按 V3.0-3 记"轻度"（原"留空"指引与 V3.0-3 及冻结抽取系统的缺省行为矛盾，会系统性压低解盲后 flag 级一致性；V3.0-3 依手册第三部分优先级高于 §四），标题改"填写规则"；③**§五 增补第 4 点**——手册 V3.1 §六为既往轮次时点口径，本轮不适用，另补"专家无需运行一致性脚本"。